Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

NFZ.2022.2 z dnia 2022.01.03

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 10 lutego 2026r.

Wejście w życie:
4 stycznia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2022/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Zarządzenie określa:

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
2) szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

§ 2.

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
   1) **Fundusz** - Narodowy Fundusz Zdrowia;
   2) **oddział Funduszu** - oddział wojewódzki Funduszu;

3) **Ogólne warunki umów** - przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach";

4) **podwykonawca** - podmiot, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

5) **rejestr** - rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120);

6) **rodzaj świadczeń** - rodzaj, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

7) **rozporządzenie szpitalne** - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

8) **rozporządzenie ambulatoryjne** - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

9) **rozporządzenie rehabilitacyjne** - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

10) **rozporządzenie kryterialne** - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach;

11) **ryczałt** - uśrednioną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki kardiologicznej w ramach Kompleksowej opieki po zawale serca (KOS-zawał), określoną w załączniku nr 4 do zarządzenia;

12) **świadczenia kompleksowe** - zakres świadczeń, o którym mowa w pkt 15, w ramach którego realizowana i finansowana jest kompleksowa opieka nad pacjentem skoordynowana przez jeden ośrodek - podmiot koordynujący, obejmująca postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne, specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne oraz w zależności od wskazań medycznych różne formy rehabilitacji;

13) **współczynnik korygujący** - współczynnik ustalany przez Prezesa Funduszu, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

14) **współrealizator** - komórkę organizacyjną w strukturze podmiotu składającego ofertę i koordynującego opiekę kompleksową, która uczestniczy w realizacji świadczeń w zakresie tej opieki;

15) **zakres świadczeń** - zakres, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

16) **zarządzenie w rodzaju leczenie szpitalne** - zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie o świadczeniach, w rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 7-10 oraz w Ogólnych warunkach umów.

Rozdział 2

Przedmiot postępowania

§ 3.

1. Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świadczeniodawców do udzielania świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczeń: leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, odpowiednio na obszarze terytorialnym:

1) województwa;

2) grupy powiatów;

3) powiatu;

4) dwóch lub więcej gmin;

5) gminy;

6) więcej niż jednej dzielnicy;

7) dzielnicy.

2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. UE L 340 z dnia 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:

1) 85110000-3 Usługi szpitalne i podobne;

2) 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;

3) 85143000-3 Usługi ambulatoryjne;

4) 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne;

5) 85141210-4 Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych.

3. Porównanie ofert w toku postępowania następuje zgodnie z art. 148 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach oraz kryteriami wyboru ofert, określonymi w rozporządzeniu kryterialnym.

4. Fundusz zawiera umowy wyłącznie ze świadczeniodawcami posiadającymi oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej, których kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, są określone w rejestrze, w części VIII systemu kodu resortowych kodów identyfikacyjnych odpowiadających lub zawierających się w zakresach, określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki umowy

§ 4.

1. Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, zwanej dalej "umową", jest realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, w zakresach określonych w **załączniku nr 3** do zarządzenia.
2. Wzór umowy określony jest w **załączniku nr 2** do zarządzenia.
3. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

§ 5.

1. Katalog świadczeń i produktów jednostkowych dedykowanych do rozliczania świadczeń, o których mowa w § 4 ust. 1, stanowiący **załącznik nr 1k** do zarządzenia, obejmuje:
   1) leczenie: diagnostykę, leczenie zachowawcze lub inwazyjne, lub zabiegowe realizowane w ramach hospitalizacji;
   2) rehabilitację realizowaną w warunkach: stacjonarnych, oddziału/ośrodka dziennego, domowych;
   3) kontrolę procesu leczenia: porady w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w **załączniku nr 4** do zarządzenia.

§ 6.

1. Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniu szpitalnym, rozporządzeniu ambulatoryjnym oraz rozporządzeniu rehabilitacyjnym.
2. Konieczność spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy każdego miejsca udzielania świadczeń, w którym realizowana jest umowa.
3. Godziny pracy personelu, określone w przepisach, o których mowa w ust. 1, mogą być tożsame z godzinami pracy personelu udzielającego świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń w

zakresach stanowiących elementy świadczeń z zakresu kompleksowej opieki.

§ 7.

1. Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", którego wzór określony jest w **załączniku nr 3** do umowy.
2. Dopuszcza się zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie części zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
3. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego wymagania, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2.
4. Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.
5. Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli każdego z podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń (w szczególności podwykonawcy) oraz o jej wynikach.
6. Zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do oddziału Funduszu w terminie umożliwiającym zmianę umowy, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem tej zmiany.

§ 8.

1. Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, których finansowanie określają odrębne przepisy.
2. Świadczeniodawca obowiązany jest do udostępniania, na żądanie Funduszu, rejestru zakażeń zakładowych.
3. Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach.
5. W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa w oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

6. W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 4, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 4 **załącznika nr 2** do zarządzenia, stanowiącego wzór umowy.

7. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.

§ 9.

1. Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", którego wzór określony jest w **załączniku nr 2** do umowy.

2. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym **załącznik nr 2** do umowy.

§ 10.

1. Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów oraz w umowie. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.

2. Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone w planie rzeczowo - finansowym, którego wzór określony jest w **załączniku nr 1** do umowy.

2a. [1] Kwota, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje finansowania świadczeń w zakresie programów lekowych.

2b. [2] Świadczenia, o których mowa w ust. 2a, finansowane są w ramach umowy PSZ w zakresie programów lekowych lub na podstawie odrębnej umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

3. Świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szczególności następujących danych:

   1) rozpoznanie zasadnicze i nie więcej niż trzy rozpoznania współistniejące - według ICD-10;

   2) istotne procedury medyczne łącznie z datą ich wykonania - według wskazanej przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9.

4. Dane, o których mowa w ust. 3, winny być zgodne z danymi:

   1) zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wydanym na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849);

2) określonymi w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120).

5. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4, stanowi warunek rozliczenia świadczeń.

6. Świadczeniodawca obowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym:

1) zakresu świadczeń, grupy według zasad określonych przez charakterystykę JGP i algorytm JGP lub produktów jednostkowych z katalogu, stanowiącego **załącznik nr 1k** do zarządzenia;

2) produktów jednostkowych określonych w katalogu produktów do sumowania, stanowiącego załączniki nr 1c i 1ts do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, o ile miały one zastosowanie.

7. Przekazanie raportu statystycznego, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, dotyczącego świadczeń z zakresu Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), następuje w oparciu o narzędzie informatyczne udostępniane przez Fundusz.

8. Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozliczeniowe odpowiadające produktom rozliczeniowym określonym w **załączniku nr 1k** do zarządzenia oraz w **załącznikach nr 1c i 1ts** do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, zatwierdzone w wyniku weryfikacji danych raportu statystycznego w systemie informatycznym Funduszu.

9. Jeżeli wartość wykonanych świadczeń w ramach Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) przekroczy kwotę zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, o której mowa w ust. 2, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania - zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz odpowiednio kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy.

10. Informacje dotyczące algorytmu JGP oraz obowiązującej w danym okresie sprawozdawczym wersji ICD-9 ogłaszane są przez Prezesa Funduszu na stronie podmiotowej Funduszu.

§ 11.

1. Jednostką rozliczeniową służącą do rozliczania produktów rozliczeniowych, o których mowa w § 5 ust. 1, jest punkt.

2. Szczegółowy opis świadczeń w zakresie Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) jest określony w **załączniku nr 4** do zarządzenia.

3. Niedopuszczalne jest dodatkowe rozliczanie przez podmiot realizujący umowę w zakresie Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) świadczeń udzielonych pacjentowi włączonemu do Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), związanych z diagnostyką inwazyjną zawału serca, leczeniem zachowawczym lub inwazyjnym zawału serca, obejmującym zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta rewaskularyzację naczyń wieńcowych lub

pomostowanie aortalno-wieńcowe, implantacją właściwego sytemu ICD lub CRT-D, rehabilitacją oraz opieką ambulatoryjną, będących przedmiotem tej umowy, na podstawie umów zawartych w innych zakresach i rodzajach świadczeń, za wyjątkiem przypadków wskazanych w **załączniku nr 4** do zarządzenia.

§ 12.

1. [3] Świadczeniodawca realizujący świadczenia w zakresie Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), w sytuacji rozliczania świadczeń związanych z żywieniem dojelitowym, żywieniem pozajelitowym oraz hipotermią leczniczą, finansowanych w ramach produktów określonych w **załączniku nr 1c** do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dodatkowej, zgodnie ze wzorami określonymi odpowiednio w **załącznikach: nr 5a, 5b, 6a- 6h** do zarządzenia. Dokumentację związaną z leczeniem żywieniowym lub monitorowaniem pacjenta podczas hipotermii leczniczej należy dołączyć do dokumentacji medycznej pacjenta.

2. W przypadku rozliczania produktu: 5.53.01.0001649 - Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, z katalogu produktów do sumowania, określonego w **załączniku nr 1c** do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, świadczeniodawca obowiązany jest do dołączenia do historii choroby podpisanego oświadczenia, którego wzór określony jest w **załączniku nr 16** do zarządzenia.

§ 12a. [4] Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne świadczenia kompleksowe w trybie hospitalizacja i hospitalizacja planowa zobowiązany jest do stosowania standardu organizacyjnego żywienia zbiorowego zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie standardu organizacyjnego żywienia zbiorowego w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne (Dz.U. poz. 1780).

§ 13. Wykazywanie przez świadczeniodawcę świadczeń do rozliczenia odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

1) poszczególne elementy opieki kompleksowej, realizowane zgodnie z potrzebami klinicznymi pacjenta w ramach leczenia szpitalnego, rehabilitacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, finansowane są osobno;

2) w przypadku udzielenia więcej niż jednego świadczenia w czasie pobytu świadczeniobiorcy w szpitalu, do rozliczenia należy wykazywać wyłącznie jedną grupę JGP z katalogu świadczeń kompleksowych, stanowiącego **załącznik nr 1k** do zarządzenia;

3) dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń finansowanych grupami z innymi produktami

rozliczeniowymi, na zasadach określonych w katalogu, stanowiącym **załącznik nr 1k** do zarządzenia;

4) dopuszcza się łączne rozliczanie grup z katalogu świadczeń kompleksowych, stanowiącego **załącznik nr 1k** do zarządzenia z produktami katalogowymi dedykowanymi do rozliczania świadczeń w OAiIT, zawartymi w katalogu świadczeń do sumowania, stanowiącym załącznik nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne i katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT, określonym w **załączniku nr 1ts** do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) finansowanie świadczeń udzielanych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS-28, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu w rodzaju leczenie szpitalne odpowiednio przez produkt rozliczeniowy o kodzie 5.52.01.0001527 - Hospitalizacja świadczeniobiorcy KOS-zawał w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - z katalogu produktów odrębnych, w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne, lub łącznego rozliczenia produktów dopuszczonych do sumowania w OAiIT z katalogu produktów do sumowania, stanowiącego **załącznik nr 1c** do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne;

6) dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń finansowanych grupami, określonymi w załączniku nr 1k do zarządzenia, z produktami katalogowymi zawartymi w katalogu produktów do sumowania, określonymi w załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, o ile w katalogu produktów do sumowania dopuszczono taką możliwość;

7) dzień przyjęcia do leczenia oraz dzień jego zakończenia wykazywany jest do rozliczenia jako jeden osobodzień;

8) jeżeli okres między udzieleniem świadczeniobiorcy świadczeń przez świadczeniodawcę, podczas odrębnych pobytów w szpitalu, z powodu określonego przez rozpoznanie lub procedurę występującą w charakterystyce danej grupy z katalogu świadczeń kompleksowych, określonego **w załączniku nr 1k** do zarządzenia, nie przekracza 14 dni, lub z zasad postępowania medycznego wynika, że problem zdrowotny może być rozwiązany jednoczasowo, świadczenia te wykazywane są do rozliczenia jako jedno świadczenie, z zastrzeżeniem pkt 9;

9) rozliczenie świadczeń w sposób określony w pkt 8 nie dotyczy hospitalizacji w celu ukończenia procesu rewaskularyzacji naczyń wieńcowych lub wykonania zabiegu kardiochirurgicznego (pomostowanie aortalno - wieńcowe), wizyty koordynującej - kontrolnej oraz rehabilitacji kardiologicznej;

10) w uzasadnionych medycznie przypadkach, dyrektor oddziału Funduszu, na umotywowany wniosek świadczeniodawcy, może wyrazić zgodę na rozliczenie określonych świadczeń związanych z ponowną hospitalizacją w okresie krótszym niż 14 dni, w tym rozpoczętą w dniu zakończenia

poprzedniej hospitalizacji;

11) w przypadkach, o których mowa w pkt 10, świadczeniodawca występuje do dyrektora oddziału Funduszu z odpowiednim wnioskiem, zgodnie ze wzorem określonym w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń, w trakcie hospitalizacji albo w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zakończenia, celem uzyskania zgody na sfinansowanie świadczenia stanowiącego przedmiot wniosku;

12) zgodę na rozliczenie świadczenia, o którym mowa w pkt 11, wydaje dyrektor oddziału Funduszu, na zasadach i w terminie określonym w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń;

13) nie dopuszcza się wyrażania zgody przez dyrektora oddziału Funduszu na rozliczanie świadczeń, w tym łącznego wykazywania do rozliczenia, w sposób inny niż określony w niniejszym zarządzeniu;

14) dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), wprowadza się współczynniki korygujące dla świadczeń, określonych w katalogu świadczeń kompleksowych, w przypadku:

a) realizacji świadczeń Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) w ramach posiadanego w strukturze organizacyjnej oddziału kardiochirurgicznego funkcjonującego w trybie całodobowym z wyodrębnionym dyżurem lekarskim, przy rozliczaniu świadczeń związanych z pomostowaniem naczyń wieńcowych w ramach grup: E04, E05G, E06G, wartość tych produktów rozliczeniowych korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,2,

b) rozpoczęcia przez pacjenta rehabilitacji kardiologicznej w terminie 14 dni od dnia wypisu ze szpitala, rozliczenie zrealizowanej rehabilitacji korygowane jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1,

c) realizacji świadczeń Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) w ramach posiadanego w strukturze organizacyjnej oddziału dziennej rehabilitacji kardiologicznej, przy rozliczaniu świadczeń z zakresu rehabilitacji dziennej, wartość tych produktów rozliczeniowych korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1,

d) wydania czynnemu zawodowo pacjentowi po zawale mięśnia sercowego, w terminie 4 miesięcy od dnia wypisu ze szpitala, zaświadczenia lekarskiego przez lekarza sprawującego opiekę nad tym pacjentem, o braku przeciwskazań ze strony układu krążenia do podjęcia/ wykonywania pracy, wartość produktów rozliczeniowych (ustalona dla leczenia i monitorowania), korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1, po wystawieniu ww. zaświadczenia,

e) pacjenta po zawale mięśnia sercowego, u którego wszystkie świadczenia wynikające z

indywidualnego planu leczenia zostały zrealizowane w terminie 12 miesięcy zgodnie z założeniami Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) - wartość produktów rozliczeniowych (ustalona dla leczenia i monitorowania) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,15, przy rozliczeniu bilansu opieki,

f) [5] (uchylona),

g) [6] (uchylona);

h) [7] świadczeniodawców, którzy osiągnęli cel terapeutyczny uzyskując co najmniej 40 % pacjentów, u których w momencie zakończenia programu wykazano obniżenie poziomu cholesterolu LDL < 55 mg/dl, wartość produktów rozliczeniowych (ustalona dla leczenia i monitorowania), korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1;

15) [8] w celu naliczenia współczynników, o których mowa w pkt 14 lit. d, e, lub h, świadczeniodawca sprawozdaje produkt rozliczeniowy o kodzie 5.56.01.0000001- Produkt premiowy KOS-zawał;

16) kwota na finansowanie Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) obejmuje procedury (wykonywane stacjonarnie i ambulatoryjnie), o których mowa w przepisach rozporządzenia szpitalnego, rozporządzenia ambulatoryjnego oraz rozporządzenia rehabilitacyjnego, a także określone w niniejszym zarządzeniu, bez uwzględnienia świadczeń w innych dziedzinach medycyny, związanych ze schorzeniami innych narządów;

17) kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) zostaje zakończona przedterminowo w przypadku, gdy:

a) nie został zrealizowany kolejny element opieki w terminie określonym w rozporządzeniu szpitalnym, rozporządzeniu ambulatoryjnym lub rozporządzeniu rehabilitacyjnym,

b) zachodzi konieczność wykonania trzeciej lub kolejnej rewaskularyzacji,

c) doszło do ponownego zawału serca,

d) pacjent kontynuuje leczenie u innego świadczeniodawcy posiadającego umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS - zawał),

e) pacjent zmarł;

18) w przypadku, o którym mowa w pkt 17:

a) rozliczeniu podlegają wyłącznie elementy opieki kompleksowej zrealizowane u pacjenta bez uwzględnienia współczynników jakościowych, o których mowa w pkt 14 lit. d lub e,

b) lit. a lub b - kontynuacja leczenia następuje w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne,

c) lit. c - rozpoczyna się nowa Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał),

d) lit. d - nowy świadczeniodawca kontynuuje Kompleksową opiekę po zawale mięśnia

sercowego (KOS-zawał), bez uwzględnienia współczynników jakościowych, o których mowa w pkt 14 lit. c - e.

§ 14.

1. Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), u których udział hospitalizowanych pacjentów z rozpoznanym ostrym zawałem serca leczonych w zakresie Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) wynosi co najmniej 60% wszystkich hospitalizowanych pacjentów z tym rozpoznaniem u tego świadczeniodawcy, wartość produktów do rozliczenia hospitalizacji (rozliczanych JGP E10, E11, E12G, E15) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,02.

2. [9] (uchylona).

3. Udział hospitalizacji, o którym mowa w ust. 1, obliczany jest na podstawie sprawozdania z realizacji świadczeń za kwartał w którym stosowany jest współczynnik.

4. [10] (uchylona).

§ 14a. [11] W przypadku rozliczania produktów rozliczeniowych 5.53.01.0005009 Wizyta koordynująca - kontrolna oraz 5.52.01.0001507 Specjalistyczna opieka kardiologiczna świadczeniodawca zobowiązany jest do sprawozdawania produktu sprawozdawczego: 5.52.01.0001574 Monitorowanie leczenia - wykonanie lipidogramu. Należy sprawozdać wszystkie wykonane badania lipidogramu w okresie stosowania terapii hipercholesterolemii w całym procesie leczenia w ramach kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego. Badanie kontrolne powinno być wykonane pomiędzy 6 a 10 tygodniem od zmiany leczenia hipolemizującego, aż do osiągnięcia docelowego stężenia cholesterolu (LDL).

§ 15. W przypadku zrealizowania rehabilitacji zgodnie z Kompleksową opieką po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), lekarz może skierować świadczeniobiorcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem kontynuowania rehabilitacji.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 16. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte.

§ 17. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy

dotychczasowe, z tym że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe zawiera się zgodnie ze wzorem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 18. Dyrektorzy oddziałów Funduszu zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

§ 19. Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 20. Traci moc zarządzenie Nr 166/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

§ 21. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Przedmiotowa regulacja dotychczas określona była w zarządzeniu Nr 166/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe (z późn. zm.), która zgodnie z § 19 zarządzenia, z dniem wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia, utraci moc obowiązującą.

Opracowanie zarządzenia ma na celu ujednolicenie przepisów oraz zachowanie ich przejrzystości, a tym samym ułatwienie interesariuszom ich stosowania.

Zmiany dokonane w niniejszym zarządzeniu obejmują:

1) dostosowanie § 4 - Warunki finansowania świadczeń oraz § 6 - Kary umowne załącznika nr 2 do zarządzenia stanowiącego wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe do przepisów § 16 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.);

2) w zakresie załącznika nr 1k do zarządzenia dodano produkt rozliczeniowy 5.53.01.0001649 - Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z możliwością jego rozliczenia w ramach stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), został poddany konsultacjom zewnętrznym na okres 14 dni. W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach. W wyniku konsultacji uwagi do projektu zgłosiły 2 podmioty. Nie dotyczyły one przedmiotu proponowanych zmian.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Skutek finansowy dla wprowadzanych niniejszym zarządzeniem zmian nie jest możliwy do oszacowania.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2022 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1k [12]

KATALOG PRODUKTÓW ROZLICZENIOWYCH DEDYKOWANYCH DO ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 2

UMOWA Nr ...../..... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWE

zawarta w ....., dnia ..... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - reprezentowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowia, w imieniu którego działa: ..... (wskazanie imienia i nazwiska osoby umocowanej) **-** ..... (wskazanie stanowiska) ..... (nazwa oddziału) **Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w** ..... (adres),

na podstawie pełnomocnictwa/pełnomocnictw[1] nr..... z dnia...../ i nr ..... z dnia...../, zwanym dalej **"Funduszem"**

a

.....

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.),

zwanym dalej "**Świadczeniodawcą**", reprezentowanym przez

.....

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, zwanych dalej "świadczeniami", w zakresie określonym w **załączniku nr 1** do umowy.

2. Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w:

1) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o świadczeniach";

2) rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydanym na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

3) rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wydanym na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

4) rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wydanym na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

5) przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów";

6) szczegółowych warunkach umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach.

3. Świadczeniodawca obowiązany jest do zapoznania z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§ 2.

1. Świadczenia gwarantowane w zakresie objętym umową udzielane są przez Świadczeniodawcę samodzielnie lub na zasadzie współpracy z innymi podmiotami leczniczymi na podstawie podwykonawstwa lub wspólnego wykonywania umowy z innymi świadczeniodawcami na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach.

2. Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy lub podwykonawców przeznaczonym do realizacji umowy, określone są w **załączniku nr 2** do umowy - "Harmonogram-zasoby".

3. Dane o wykazie współrealizatorów określone są **w załączniku nr 5** do umowy.

4. W przypadku realizacji umowy przez Świadczeniodawcę we współpracy z innymi podmiotami leczniczymi, "Wykaz podwykonawców" stanowi **załącznik nr 3** do umowy.

5. W przypadku wspólnej realizacji umowy na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach, dane o potencjale wykonawczym świadczeniodawców innych niż podmiot koordynujący (co do zasady podpisujący umowę, z zastrzeżeniem wspólnego wykonywania umowy z innymi świadczeniodawcami na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach - szpital posiadający oddział o profilu kardiologicznym) wykazywane są z zastosowaniem **załącznika nr 2** do umowy.

6. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty spełniające warunki określone dla Świadczeniodawców w szczegółowych warunkach umów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 oraz w przepisach odrębnych.

7. Dopuszczalne jest zlecanie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń oraz jej wynikach.

9. Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w **załączniku nr 3** do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu

najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.

10. Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji wszystkich podmiotów biorących udział w realizacji umowy, służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i wymagany sprzęt.

11. Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 9 i 10, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.

12. Świadczeniodawca jest obowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.

§ 3. Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy, jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy o świadczeniach.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§ 4.

1. Kwota zobowiązania Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ..... r. do dnia ..... r., wynosi maksymalnie.....zł (słownie: .....zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera środki wynikające z określenia współczynników korygujących, o których mowa w § 16 Ogólnych warunków umów.

3. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków wynikających z określenia współczynników korygujących, o których mowa w § 16 ust. 3 lub ust. 4a Ogólnych warunków umów, w sposób określony w § 16 ust. 3, 4, 4b i 4c Ogólnych warunków umów, kwota przekazanych Świadczeniodawcy środków podlega zwrotowi.

4. Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w zakresie świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący **załącznik nr 1** do umowy.

5. W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń, o których mowa w ust. 1, przekroczy określoną dla nich kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie - odpowiedniemu zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.

6. Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń Fundusz wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego:..... nr .....

7. [13] Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6, wymaga uprzednio złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia albo w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi **załącznik nr 4** do umowy.

8. Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.

9. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).

10. Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCÓW

§ 5.

1. Świadczeniodawca obowiązany jest do przekazywania Funduszowi za dany okres sprawozdawczy podlegający rozliczeniu w ramach umowy, informacji o realizacji świadczeń, sporządzonej na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, Świadczeniodawca przekazuje do Oddziału Funduszu comiesięcznie w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych wymaganym przez Oddział Funduszu, w zakresie wskazanym w **załączniku nr 4** szczegółowych warunków umów**,** o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6.

KARY UMOWNE

§ 6.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.

2. [14] W przypadku wystawienia recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego lub wyroby medyczne objęte refundacją, osobom nieuprawnionym lub przez osobę niebędącą osobą uprawnioną lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen tych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

3. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, z późn. zm.), finansowanych w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

4. W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.

5. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, wynikających z ustalenia współczynników korygujących, o których mowa w § 16 ust. 3 lub ust. 4a Ogólnych warunków umów, w sposób określony w § 16 ust. 3, 4, 4b i 4c Ogólnych warunków umów, Fundusz nakłada na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 - 5, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

7. Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 7.

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ..... do dnia .....r.

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla siedziby oddziału wojewódzkiego Funduszu.

§ 9. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się w szczególności przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzeń, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 10. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

§ 11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1) **Załącznik nr 1 do umowy** - Plan rzeczowo - finansowy;

2) **Załącznik nr 2 do umowy** - Harmonogram - zasoby;

3) **Załącznik nr 3 do umowy** - Wykaz podwykonawców;

4) **Załącznik nr 4 do umowy** - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego;

5) **Załącznik nr 5 do umowy** - Wykaz współrealizatorów.

PODPISY STRON

.....	.....
.....	.....
Świadczeniodawca	**Fundusz**

Objaśnienia:

[1] niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał nr 1 do umowy nr ..... **rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe wersja .....**	**Nr dokumentu (aneksu) wprowadzającego:.....** **OW NFZ**
Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ	
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	

finansowanych ze środków publicznych	

ROK ..... - Kwota umowy dla wszystkich okresów sprawozdawczych ..... zł (słownie - .....)

Okres rozliczeniowy od..... do.....

Pozycja	Podstawa *	Kod zakresu świadczeń	Zakres świadczeń	Kod miejsca udzielania świadczeń	Jednostka rozliczeniowa	Liczba jednostek rozliczeniowych	Cena jedn. rozlicz. (zł)	Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)								

Okres rozliczeniowy od..... do.....**

Pozycja	Podstawa *	Kod zakresu świadczeń	Zakres świadczeń	Kod miejsca udzielania świadczeń	Jednostka rozliczeniowa	Liczba jednostek rozliczeniowych	Cena jedn. rozlicz. (zł)	Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)								

w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje

	Okres sprawozd.	Wartość (zł)	Okres sprawozd.	Wartość (zł)	Okres sprawozd.	Wartość (zł)	Okres sprawozd.	Wartość (zł)

Razem pozycje			Styczeń		Luty		Marzec		Kwiecień	
			Maj		Czerwiec		Lipiec		Sierpień	
			Wrzesień		Październik		Listopad		Grudzień	
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje										
Pozycja		Kod zakresu		Nazwa zakresu						
Kod miejsca		Nazwa miejsca								
Adres miejsca								TERYT		

	Styczeń	Luty	Marzec
liczba * cena			
wartość			
	Kwiecień	Maj	Czerwiec
liczba * cena			
wartość			
	Lipiec	Sierpień	Wrzesień
liczba * cena			
wartość			
	Październik	Listopad	Grudzień
liczba * cena			

wartość			

data
sporządzenia

Fund
usz***

świadczeniodawca
****

* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie
której została utworzona pozycja umowy

** - Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)

*** kwalifikowany podpis elektroniczny
albo pieczęć wraz z podpisem

**** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka świadczeniodawcy - zawierające nazwę, adres, NIP i REGON - wraz z podpisem

Załącznik Nr 2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik nr ..... do umowy nr .....

Pozycja		**Kod zakresu**		**Nazwa zakresu**			
I. Miejsce udzielania świadczeń							
Kod miejsca (a)	Id podwyk. (b)	Nazwa miejsca (c)	Adres miejsca (d)	VII cz.KR* (e)	VIII cz. KR* (f)	Profil IX-X cz.KR* (g)	Status**

II. Dostępność miejsca udzielania świadczeń														
pn (a)	wt (b)	śr (c)	czw (d)	pt (e)	sob (f)	nd (g)	Obowiązuje od (h)	Obowiązuje do (i)	Status **					

III. Personel											
Id osoby (a)	Nazwisko (b)	Imiona (c)	PESEL (d)	Zawód/specjalność (e)	St.spec jal. (f)	NPWZ (g)	Tyg. lb. godzin (h)	Obowiązuje od (i)	Obowiązuje do (j)	Status **

IV. Sprzęt								
Id sprzętu (a)	Nazwa sprzętu (b)	Ilość (c)	Nr seryjny (d)	Rok produkcji (e)	Rodzaj dostępności (f)	Dostępny od (g)	Dostępny do (h)	Status **

Fundusz***

świadczeniodawca****

* KR (Kody resortowe) - kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 r. poz. 711, z późn. zm.)

** B - brak zmian, D - dodano, M -

zmodyfikowano, U -
usunięto

*** kwalifikowany podpis
elektroniczny albo pieczęć wraz
z podpisem

**** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/
naklejka świadczeniodawcy - zawierające nazwę, adres, NIP i
REGON - wraz z podpisem

Załącznik Nr 3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW **Załącznik nr ..... do umowy nr .....** **rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe**			
UNIKALNY WYRÓŻNIK PODWYKONAWCY			
Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy			
Nazwa			
Adres siedziby			
Kod terytorialny i nazwa			
REGON		NIP	
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)			
Osoba/y uprawniona do reprezentowania		Telefon	
Dane rejestrowe podwykonawcy			
		Nr wpisu do	

Rodzaj rejestru		rejestru	
Organ rejestrujący		Data wpisu	
		Data ostatniej aktualizacji	
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa			
Umowa/promesa			
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowa		Pozycja/e umowy	
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowa		Przedmiot świadczeń podwykonywanych	
Opis przedmiotu podwykonawstwa			
data sporządzenia			
Fundusz*		świadczeniodawca **	
* kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć wraz z podpisem			
** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka świadczeniodawcy - zawierające nazwę, adres, NIP i REGON - wraz z podpisem			

Załącznik Nr 4 [15]

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

grafika

Załącznik Nr 5

WYKAZ WSPÓŁREALIZATORÓW

Załącznik nr ..... do umowy nr .....

rodzaj świadczeń:.....

UNIKALNY WYRÓŻNIK WSPÓŁREALIZATORA			
Dane identyfikacyjne i adresowe współrealizatora			
Nazwa			
Adres siedziby			
Kod terytorialny i nazwa			
REGON		NIP	
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)			
Osoba/y uprawniona do reprezentowania		Telefon	
Dane rejestrowe współrealizatora			
Rodzaj rejestru		Nr wpisu do rejestru	
Organ rejestrujący		Data wpisu	
		Data ostatniej aktualizacji	
Dane dotyczące zakresu współrealizacji			
Umowa/promesa			
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać zakres współrealizacji		Pozycja/e umowy	
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać zakres współrealizacji		Przedmiot świadczeń współrealizatora	
Opis przedmiotu			

współrealizacji			
data sporządzenia			
Fundusz*		świadczeniodawca**	
* kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć wraz z podpisem			
** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka świadczeniodawcy - zawierające nazwę, adres, NIP i REGON - wraz z podpisem			

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WARUNKI WYMAGANE DO ZAWARCIA UMOWY

Nazwa zakresu świadczeń
1. Kod zakresu: 03.4100.500.02 - KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-zawał)
1.1 WARUNKI WYMAGANE - realizacja świadczeń zgodnie z warunkami określonymi w Lp. 36 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Realizacja świadczeń, zgodnie z indywidualnym stanem klinicznym pacjenta z rozpoznaniami wg ICD-10: I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.0, I22.1, I22.9, obejmuje: 1 leczenie szpitalne; 2 rehabilitację kardiologiczną; 3 kardiologiczną opiekę specjalistyczną.
1.1.1 WARUNKI WYMAGANE DLA LECZENIA SZPITALNEGO - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
1) warunki ogólne - wynikające z § 4 ust. 1 pkt 1 - 7, § 5, § 5a, § 6, § 6a, § 6b, § 7 i § 9 rozporządzenia szpitalnego; 2) warunki szczegółowe - wynikające z części I Lp. 24 załącznika nr 3 oraz Lp. 7 załacznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego: - spełnienie wymagań określonych w Lp. 24 Kardiologia lit. A leczenie osób, które ukończyły 18. rok życia, - spełnienie wymagań określonych w Lp. 7 Leczenie inwazyjne OZW, (...) lit. A Leczenie osób, które ukończyły 18. rok życia;

1.1.2 WARUNKI WYMAGANE DLA REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ - zgodnie z obowiązującym załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej	
1.1.3 WARUNKI WYMAGANE DLA KARDIOLOGICZNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ - zgodnie z lp. 21 załącznika nr 5 do obowiązujacego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	
1.2 WARUNKI WYMAGANE - do zawarcia umowy	
1.2.1 Wymagania formalne	1) Posiadanie w strukturze organizacyjnej (wpis w rejestrze): oddziału szpitalnego o profilu kardiologia, 2) Posiadanie w strukturze organizacyjnej lub na podstawie podwykonawstwa lub na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach: - pracowni radiologii zabiegowej lub pracownii hemodynamiki oraz pracownii elektrofizjologii, - oddziału szpitalnego o profilu kardiochirurgia, - oddziału stacjonarnego rehabilitacji kardiologicznej lub ośrodka albo oddziału dziennego rehabilitacji kardiologicznej, - poradni specjalistycznej o profilu kardiologia.
1.2.2 Organizacja udzielania świadczeń	1) Harmonogram udzielania świadczeń w ramach opieki koordynowanej nie może ograniczać dostępności do świadczeń realizowanych w ramach innych umów. 2) Całodobowa możliwość kontaktu telefonicznego (w ramach oddziału kardiologicznego) dla pacjentów objetych kompleksową opieką
1.2.3 Pozostałe warunki	Koordynacja wszystkich działań związanych z opieką nad pacjentem w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca zgodnie z opisem KOS-zawał.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 [16]

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Opis świadczenia

KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-zawał)

1.	**Charakterystyka świadczenia**	
1.1	Nazwa zakresu świadczeń	**Kod zakresu 03.4100.500.02: Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)**
	Kryteria kwalifikacji świadczeniobiorc	

1.2	ów wymagających udzielenia świadczenia	Zgodnie z załącznikiem nr 4 lp. 36 do rozporządzenia szpitalnego.
1.3	Określenie świadczenia	Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej określone w lp. 36 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego, lp. 21 załącznika nr 5 do rozporządzenia ambulatoryjnego oraz załączniku nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego.
1.4	Częstość występowania zgonów sercowo - naczyniowych	W Polsce w ciągu roku po wystąpieniu zawału około 38% wszystkich obserwowanych zgonów ma podłoże sercowo - naczyniowe.
1.5	Specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania	C53 Morfologia krwi 8-parametrowa L43 Glukoza N45 Potas (K) M37 Kreatynina K01 Cholesterol HDL K03 Cholesterol LDL 181 stężenie białka C-reaktywnego (CRP) 117 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 00.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu 00.41 Zabieg na dwóch naczyniach 00.42 Zabieg na trzech naczyniach 00.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach 00.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego 00.46 Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowych 00.47 Wprowadzenie trzech stentów naczyniowych 00.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentów naczyniowych 00.50 Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji [CRT-P]00.51 Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D]

	świadczenia	00.531 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P] 00.532 Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca 00.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora 00.661 Przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu 00.662 Aterektomia wieńcowa 00.668 Przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu tnącego 36.061 Wprowadzenie stentu (ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych,
		do naczynia wieńcowego - stent niepowlekany 36.062 Wprowadzenie stentu (ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent powlekany 36.063 Wprowadzenie stentu (ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent pokrywany, np. heparyną 36.065 Wprowadzenie stentu samorozprężalnego do tętnicy wieńcowej 36.070 Wprowadzenie jednego stentu uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej 36.071 Wprowadzenie dwóch stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowe 36.072 Wprowadzenie trzech stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej (zmiana krotności poprzez kod procedury) 36.073 Wprowadzenie czterech stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej (zmiana krotności poprzez kod procedury) 36.074 Wprowadzenie pięciu stentów uwalniających leki do

		tętnicy wieńcowej 36.091 Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej 36.101 Bezpośrednia rewaskularyzacja mięśnia sercowego przy pomocy wewnętrznego poszerzenia światła tętnicy wieńcowej/ sztucznej wstawki naczyniowej/żyły jako wstawki naczyniowej 36.11 Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa) 36.12 Pomosty aortalno-wieńcowe (2 tętnice wieńcowe) 36.13 Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe) 36.15 Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie) 36.16 Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna - tętnice wieńcowe (dwa naczynia) 36.17 Pomost brzuszno-wieńcowy 36.19 Pomosty dla rewaskularyzacji serca - inne 37.21 Cewnikowanie prawego serca 37.22 Cewnikowanie lewego serca 37.23 Cewnikowanie lewego i prawego serca 37.261 Badania elektrofizjologiczne [EPS] 37.80 Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne 37.82 Wszczepienie rozrusznika jednojamowego 37.83 Wszczepienie rozrusznika dwujamowego 37.86 Wymiana rozrusznika jednojamowego 37.87 Wymiana rozrusznika dwujamowego 37.941 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego 37.943 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego 37.947 Wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S- ICD) 37.948 Wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD) 88.522 Angiokardiografia: prawego przedsionka	

		88.523 Angiokardiografia: prawej komory (drogi wypływu) 88.532 Angiokardiografia: lewego przedsionka 88.533 Angiokardiografia: lewej komory (drogi wypływu) 88.54 Angiokardiografia lewego i prawego serca 88.55 Koronarografia z użyciem jednego cewnika lub 88.56 Koronarografia z użyciem dwóch cewników 89.00 Badanie i porada lekarska, konsultacja 89.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej 89.43 Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym 89.442 Sześciominutowy test marszu 89.511 Elektrokardiografia z 1-3 odprowadzeniami lub 89.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem) 93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna 93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe
		93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem 93.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym 93.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym 93.3603 Trening stacyjny 93.3604 Trening marszowy 93.3605 Trening marszowy z przyborami 94.08 Ocena stanu psychicznego 94.335 Trening autogenny oraz w uzasadnionych klinicznie przypadkach inne procedury ICD-9 zawarte w rozporządzeniu szpitalnym, w rozporządzeniu ambulatoryjnym, w rozporządzeniu rehabilitacyjnym.
		Kompleksowa opieka kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego oparta na wdrożeniu leczenia interwencyjnego oraz kardiochirurgicznego ma zapewnić właściwe postępowanie terapeutyczne z pacjentami po zawale serca i obniżyć śmiertelność szpitalną oraz wczesną po incydencie sercowo-naczyniowym.

1.6	Oczekiwane wyniki postępowania	Wczesna rehabilitacja kardiologiczna i monitorowanie w ramach kardiologicznej opieki specjalistycznej wskaźników dotyczących jakości opieki nad pacjentem ma zapewnić właściwą kontrolę czynników ryzyka, co może wpłynąć pozytywnie na obniżenie odsetka śmiertelności odległej, jak również ma na celu przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.
2.	**Warunki wykonania i finansowania świadczenia**	
2.1	Warunki wykonania świadczenia	Zgodnie z warunkami określonymi w lp. 36 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego, w lp. 21 załącznika nr 5 do rozporządzenia ambulatoryjnego oraz w załączniku nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego.
2.2	Organizacja udzielania świadczenia	Zgodnie z warunkami określonymi w lp. 36 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego, lp. 21 załącznika nr 5 do rozporządzenia ambulatoryjnego oraz załączniku nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego. Kompleksowa opieka skoordynowana przez jeden ośrodek - podmiot koordynujący, realizowana jest w różnych komórkach organizacyjnych (podmiotach), zgodnie ze schematem organizacyjnym realizacji kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), opracowanym przez podmiot koordynujący. Podmiotem koordynującym jest szpital posiadający oddział kardiologiczny. W przypadku, gdy pacjent po diagnostyce inwazyjnej nie kwalifikuje się do objęcia opieką w ramach KOS-zawał, odnotowuje ten fakt w historii choroby oraz niezwłocznie w systemie informatycznym dedykowanym do monitorowania KOS-zawał, po jego udostępnieniu przez NFZ. Po zakończeniu udzielania świadczenia w ramach KOS-zawał podmiot koordynujący przekazuje informacje lekarzowi POZ/AOS o świadczeniach zalecanych pacjentowi.

		Opieka nad pacjentem po zawale serca obejmuje leczenie, rehabilitację i monitorowanie procesu terapeutycznego.
		LECZENIE obejmuje: 1) hospitalizację pacjenta z powodu zawału serca w trakcie której zastosowano: a) diagnostykę inwazyjną zawału serca (koronarografię) lub leczenie zachowawcze, lub b) leczenie inwazyjne, obejmujące m.in. pełną rewaskularyzację naczyń wieńcowych lub zabieg kardiochirurgiczny (odpowiednio do stanu klinicznego pacjenta): - rewaskularyzację I-etapową - w trakcie hospitalizacji z powodu zawału serca, - rewaskularyzację II-etapową, która może być realizowana przy pierwszej hospitalizacji z powodu zawału serca albo rozłożona na dwie hospitalizacje (pierwszą z powodu zawału serca oraz drugą hospitalizację planową); 2) elektroterapię, w tym:
		a) wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego, b) wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego, c) wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT), d) wszczepienie kardiowertera-defibrylatora (ICD), e) wszczepienie kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizującą (CRT- D) albo f) wszczepienie / wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD) - po dokonaniu u pacjenta oceny frakcji wyrzutowej 3) ustalony w trakcie hospitalizacji przez lekarza kardiologa indywidualny plan leczenia pacjenta uwzględniający odpowiednią rehabilitację kardiologiczną i wizyty w poradni kardiologicznej; 4) Leczenie farmakologiczne: w przypadku spełnienia przez pacjenta kryteriów do objęcia leczeniem w ramach programu lekowego - możliwość finansowania świadczenia w ramach umowy PSZ w zakresie dotyczącym programów lekowych lub na podstawie odrębnej umowy w rodzaju leczenie szpitalne w

		zakresie programy lekowe. Plan leczenia pacjent należy załączyć do dokumentacji medycznej pacjenta; **REHABILITACJA** obejmuje**:** 1) rehabilitację kardiologiczną lub hybrydową telerehabilitację kardiologiczną realizowaną w warunkach stacjonarnych; lub 2) rehabilitację kardiologiczną lub hybrydową telerehabilitację kardiologiczną realizowaną w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego -zgodnie z kryteriami kwalifikacji oraz warunkami wymaganymi do jej realizacji określonymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego. **MONITOROWANIE obejmuje:** 1) wizytę koordynującą (kontrolną): wykonanie badań elektrokardiograficznych i badań laboratoryjnych: morfologia krwi, stężenie potasu we krwi, stężenie kreatyniny we krwi, stężenie białka C-reaktywnego (CRP), wystawienie skierowania na badanie lipidogramu, które powinno być wykonane w okresie pomiędzy 6 a 10 tygodniem od zmiany leczenia hipolemizującego, a także edukację pacjenta przez personel pielęgniarski; 2) specjalistyczną opiekę kardiologiczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca zgodnie z indywidualnym planem leczenia [w tym porady obejmujące kwalifikację do implantacji całkowitego automatycznego sytemu do kardiowersji lub defibrylacji (system ICD), układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji (system CRT-D) lub całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (system S-ICD) oraz poradę monitorującą urządzenia wszczepialne]; liczba konsultacji i ich częstość powinna być ustalona w zależności od stanu klinicznego pacjenta; 3) poradę specjalistyczną kończącą opiekę w ramach KOS-zawał: wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych, w tym lipidogramu; - w przypadku nieosiągnięcia celu terapeutycznego wizyta kontrolna powinna być sprawozdawana każdorazowo

2.3	Zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia	Zgodnie z załącznikiem nr 1 k do zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe: kardiologia, kardiochirurgia, rehabilitacja medyczna.
2.4	Warunki i etapy finansowania świadczenia	Finansowanie poszczególnych etapów kompleksowej opieki, realizowanych zgodnie z potrzebami klinicznymi pacjentów, obejmuje: 1) w zakresie leczenia: a) diagnostykę inwazyjną, leczenie zachowawcze lub leczenie inwazyjne, obejmujące zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta rewaskularyzację naczyń wieńcowych, lub pomostowanie aortalno-wieńcowe, realizowane w ramach hospitalizacji - rozliczane w ramach JGP z katalogu świadczeń kompleksowych,
		b) dodatkowe świadczenia rozliczane produktami jednostkowymi ujętymi w katalogu produktów do sumowania (zał. 1c i 1ts do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne) - możliwe do sumowania z właściwą JGP z katalogu świadczeń kompleksowych, c) opracowanie indywidualnego planu kompleksowego leczenia po zawale serca - rozliczane produktem z katalogu świadczeń kompleksowych dedykowanym do sumowania z właściwą JGP z tego katalogu, d) elektroterapię*, -rozliczane w ramach właściwej JGP z katalogu świadczeń kompleksowych; * W sytuacji implantacji u pacjenta właściwego sytemu ICD, CRT-D lub S-ICD podmiot koordynujący obowiązany jest do posiadania dokumentu (nośnika) z zarejestrowanymi parametrami frakcji wyrzutowej lewej komory serca. 2) w zakresie rehabilitacji: a) rehabilitację kardiologiczną stacjonarną - rozliczaną w ramach grupy RKZ z katalogu świadczeń kompleksowych, b) rehabilitację kardiologiczną w ośrodku oddziale dziennym i hybrydową

		telerehabilitację kardiologiczną realizowaną w miejscu pobytu pacjenta - rozliczaną osobodniami w ramach produktów w katalogu świadczeń kompleksowych 3) w zakresie monitorowania: 1) wizytę koordynującą (kontrolną) - rozliczaną produktem z katalogu świadczeń kompleksowych; 2) kardiologiczną opiekę specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca, obejmującą: a) realizację co najmniej 3 porad u pacjenta w okresie objęcia KOS-zawał - rozliczanych ryczałtem po ich zrealizowaniu w ramach produktu w katalogu świadczeń kompleksowych, b) poradę specjalistyczną wraz z przeprowadzeniem bilansu opieki u pacjenta kończącego opiekę w ramach KOS-zawał (badania i ocena stanu klinicznego) - rozliczaną w ramach produktu rozliczeniowego: "Specjalistyczna opieka kardiologiczna - bilans opieki" z katalogu świadczeń kompleksowych.
3.	**Dane do sprawozdawczości**	
		Zgodnie z systemem informatycznym udostępnionym przez Fundusz.
4.	**Istniejące wytyczne postępowania medycznego**	
		Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczącymi postępowania z chorymi z zawałem serca.
5.	**Parametry jakościowe do oceny udzielania świadczeń**	
		Monitorowanie i ewaluacja programu opieki kompleksowej nad pacjentem po zawale serca będzie obejmowała zarówno wskaźniki dotyczące jakości opieki nad pacjentem na poziomie ośrodka realizującego program opieki kompleksowej, jak i wskaźniki dotyczące efektów leczenia. Świadczeniodawca realizujący KOS - zawał mierzy i ocenia wskaźniki określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia szpitalnego lp. 36 część "Pozostałe wymagania" kolumna nr 4 ust.

		3. Parametry stosowane do oceny efektów opieki kompleksowej u pacjentów po zawale serca po 12 miesiącach jej realizacji - na podstawie danych
		sprawozdawczych przez świadczeniodawców do sytemu informatycznego NFZ: 1) procentowy udział pacjentów po zawale mięśnia sercowego objętych KOS- zawał; 2) odsetek pacjentów, u których zrealizowany został cały zindywidualizowany schemat opieki; 3) odsetek rehospitalizacji z przyczyn sercowo - naczyniowych; 4) odsetek pacjentów, u których wykonano zabieg angioplastyki wieńcowej w ramach II etapu rewaskularyzacji; 5) odsetek pacjentów, którym wszczepiono kardiowerter/ defibrylator ICD; 6) odsetek pacjentów, którym wszczepiono kardiowerter/ defibrylator CRT-D; 7) odsetek pacjentów, którym wszczepiono całkowicie podskórny kardiowerter/defibrylator S-ICD; 8) procentowy udział wystąpienia zgonu po zawale z powodu epizodu sercowo- naczyniowego w okresie: a) 6 miesięcy od dnia wystąpienia zawału serca, b) 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca. 9) odsetek pacjentów, u których w momencie zakończenia programu wykazano obniżenie poziomu cholesterolu LDL < 55 mg/dl.

[1] § 10 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 133/2023/DSOZ z dnia 11 września 2023 r. (NFZ.2023.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 września 2023 r.

[2] § 10 ust. 2b dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 133/2023/DSOZ z dnia 11 września 2023 r. (NFZ.2023.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 września 2023 r.

[3] § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 38/2024/DSOZ z dnia 29 marca 2024 r. (NFZ.2024.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2024 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 kwietnia 2024 r., zgodnie z § 4 powołanego zarządzenia.

[4] § 12a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 18/2026/DSOZ z dnia 9 lutego 2026 r. (NFZ.2026.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2026 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2026 r., zgodnie z § 5 zarządzenia zmieniającego.

[5] § 13 pkt 14 lit. f uchylona przez § 1 zarządzenia nr 77/2025/DSOZ z dnia 1 września 2025 r. (NFZ.2025.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 września 2025 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 września 2025 r., zgodnie z § 4 powołanego zarządzenia.

[6] § 13 pkt 14 lit. g uchylona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 174/2022/DSOZ z dnia 27 grudnia 2022 r. (NFZ.22.174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 grudnia 2022 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2023 r., zgodnie z § 4 powołanego zarządzenia.

[7] § 13 pkt 14 lit. h dodana przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 133/2023/DSOZ z dnia 11 września 2023 r. (NFZ.2023.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 września 2023 r.

[8] § 13 pkt 15 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 133/2023/DSOZ z dnia 11 września 2023 r. (NFZ.2023.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 września 2023 r.

[9] § 14 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 174/2022/DSOZ z dnia 27 grudnia 2022 r. (NFZ.22.174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 grudnia 2022 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2023 r., zgodnie z § 4 powołanego zarządzenia.

[10] § 14 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 174/2022/DSOZ z dnia 27 grudnia 2022 r. (NFZ.22.174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 grudnia 2022 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2023 r., zgodnie z § 4 powołanego zarządzenia.

[11] § 14a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 133/2023/DSOZ z dnia 11 września 2023 r. (NFZ.2023.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 września 2023 r.

[12] Załącznik nr 1k:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 39/2023/DSOZ z dnia 17 lutego 2023 r. (NFZ.2023.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 2023 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 lutego 2023 r., zgodnie z § 3 powołanego zarządzenia.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 40/2023/DSOZ z dnia 23 lutego 2023 r. (NFZ.2023.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 2023 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 133/2023/DSOZ z dnia 11 września 2023 r. (NFZ.2023.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 września 2023 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 38/2024/DSOZ z dnia 29 marca 2024 r. (NFZ.2024.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2024 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 kwietnia 2024 r., zgodnie z § 4 powołanego zarządzenia.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 64/2025/DSOZ z dnia 23 lipca 2025 r. (NFZ.2025.64) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 2025 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 lipca 2025 r., zgodnie z § 4 powołanego zarządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 18/2026/DSOZ z dnia 9 lutego 2026 r. (NFZ.2026.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2026 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2026 r., zgodnie z § 5 zarządzenia zmieniającego.

[13] Załącznik nr 2 § 4 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia nr 38/2024/DSOZ z dnia 29 marca 2024 r. (NFZ.2024.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2024 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 kwietnia 2024 r., zgodnie z § 4 powołanego zarządzenia.

[14] Załącznik nr 2 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 133/2023/DSOZ z dnia 11 września 2023 r. (NFZ.2023.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 września 2023 r.

[15] Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 38/2024/DSOZ z dnia 29 marca 2024 r. (NFZ.2024.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2024 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 kwietnia 2024 r., zgodnie z § 4 powołanego zarządzenia.

[16] Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 133/2023/DSOZ z dnia 11 września 2023 r. (NFZ.2023.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 września 2023 r.